

Afastamentos por transtornos mentais entre trabalhadores do Nordeste brasileiro: um estudo ecológico

Sick leave due to occupational mental disorders in Brazil
Northeastern states: an ecological study

Paula Beatriz de Souza **Mendonça**¹, Izabelle Bezerra **Costa**¹,
Vanessa Cristina de Góes e Silva Faustino da **Costa**¹*, Janete Lima de **Castro**¹

RESUMO | Introdução: Mesmo diante dos benefícios que a atividade laboral proporciona, tem-se observado um aumento significativo no número de trabalhadores com sofrimento psíquico, depressão e doenças associadas ao estresse. **Objetivos:** Identificar e apresentar a distribuição espacial por estado do Nordeste dos principais transtornos mentais e comportamentais que geram afastamento da atividade laboral. **Métodos:** Realizou-se um estudo descritivo com desenho ecológico de série temporal, cuja finalidade é identificar a distribuição de transtornos mentais e comportamentais em trabalhadores da região Nordeste. Para a coleta de dados, utilizou-se o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab) mediante o *download* das informações notificadas no período de 2012 a 2018. A análise foi realizada por meio da linguagem de programação Python. **Resultados:** As concessões de auxílios por afastamento conforme o tipo de doença foram registradas para afastamentos não acidentários (B31) e acidentários (B91). A Bahia apresentou um maior número de casos notificados para B31, assim como o Rio Grande do Norte para B91. O Rio Grande do Norte e Alagoas se destacaram como os estados que concentram o maior percentual de casos de afastamento por transtornos mentais e comportamentais. Os transtornos fóbico-ansiosos obtiveram o maior número de notificações entre os estados. A atividade de construção de edifícios se revelou com os maiores números de notificações relacionadas ao trabalho. **Conclusões:** Este estudo contribuiu para a identificação dos principais transtornos que acometem os trabalhadores. É necessário que sejam adotadas políticas públicas no enfrentamento da crise de saúde pública que impacta diretamente as condições sociais e econômicas do país.

Palavras-chave | saúde do trabalhador; saúde mental; licença médica.

ABSTRACT | Introduction: Although work provides many benefits, occupational mental disorders, such as mental distress, depression, and stress-related illnesses have significantly increased. **Objectives:** This study aims to identify and present the spatial distribution of the major mental and behavioral disorders that lead to sick leave in Brazil Northeastern states. **Methods:** This descriptive study with an ecological time series design aimed to identify the distribution of occupational mental and behavioral disorders in Brazil Northeastern states. Data collection included downloading information from the Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab, Occupational Health and Safety Observatory) from 2012 to 2018. Data were analyzed using Python. **Results:** Grants of sick leave according to the type of illness were recorded for nonaccident-related leave (B31) and accident-related leave (B91). Bahia had the highest number of cases reported for B31, as did Rio Grande do Norte for B91. Rio Grande do Norte and Alagoas stood out with the highest rates of sick leave due to mental and behavioral disorders. Phobic-anxiety disorders had the highest number of notifications. The building construction industry had the highest number of work-related notifications. **Conclusions:** This study has contributed to identifying the main occupational disorders. Public policies need to be implemented to tackle the public health crisis which directly impacts on domestic social and economic conditions.

Keywords | occupational health; mental health; sick leave.

¹ Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.

* *In memoriam*

Fonte de financiamento: Nenhuma

Conflitos de interesse: Nenhum

Como citar: Mendonça PBS, Costa IB, Costa VCGSF, Castro JL. Sick leave due to occupational mental disorders in Brazil Northeastern states: an ecological study. Rev Bras Med Trab. 2024;22(2):e20221007. <http://doi.org/10.47626/1679-4435-2022-1007>

INTRODUÇÃO

O trabalho representa para o homem um sentido de vida. Por ser uma atividade essencialmente humana, é considerado um meio de subsistência que cria perspectivas existenciais e auxilia na construção e estruturação da identidade e personalidade do sujeito¹. Essa compreensão tem sido resultado de uma idealização consolidada ao longo do tempo, que está presente no cotidiano do indivíduo².

No que concerne à qualidade de vida do trabalhador, a literatura aponta o trabalho humano como um importante agente promotor de saúde para quem o realiza. Em contrapartida, mesmo diante de concepções favoráveis acerca do trabalho e de seus benefícios, observa-se um aumento significativo no número de trabalhadores que apresentam sofrimento psíquico, depressão e doenças associadas ao estresse – situação que remete ao sentido de trabalho como fonte de desgaste e sofrimento³.

Aspectos como as condições do ambiente laboral, o incentivo à competição entre os colaboradores, a redução na oferta de vagas de emprego, o aumento da terceirização de funcionários, entre outros fatores impactam significativamente no desenvolvimento de transtornos mentais e comportamentais (TMCs)^{4,5}. Diante disso, o adoecimento mental surge como uma resposta do organismo ao contexto externo no qual o trabalhador encontra-se inserido, tecendo, assim, uma existência relacional entre o trabalho e o adoecimento mental⁶.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam para dados que correlacionam fatores psicossociais no trabalho ao efeito sobre a saúde do trabalhador. De acordo com a pesquisa realizada, trabalhadores expostos a estressores psicossociais nocivos no ambiente de trabalho tendem a apresentar sintomas psiquiátricos e psicossomáticos e mudanças no bem-estar subjetivo e na qualidade de vida⁷.

No Brasil, observa-se que os TMCs são um dos principais causadores de afastamentos laborais por apresentarem como consequências incapacidade e baixa produtividade dos indivíduos acometidos. Nessa perspectiva, considerando o cenário nacional, dados apontam que, nos últimos anos, o adoecimento mental assume a terceira posição como causa de afastamento por auxílio-doença, elegendo-se como um dos principais fatores de concessão de benefício previdenciário⁷.

O Nordeste é a segunda região do país que mais solicita benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A distribuição de auxílios emitidos por áreas, em 2017, era de 20,1% em áreas urbanas e de 57,9% em áreas rurais. Já por distribuição de benefícios ativos, 19% destinavam-se a áreas urbanas e 49,1%, a áreas rurais. Os afastamentos por TMCs são categorizados no Capítulo V da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10)⁸.

O afastamento por transtornos mentais em trabalhadores, além de impactar economicamente a sociedade e o indivíduo, afeta a saúde do trabalhador e a sua qualidade de vida, o incapacitando para o trabalho laboral. Diante disso, para a condução do estudo, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: “Qual a distribuição espacial e quais os transtornos mentais que mais geram afastamento da atividade laboral entre trabalhadores nos estados da região Nordeste?”.

Considerando a magnitude do problema social e suas repercussões no processo saúde-doença do trabalhador, o objetivo do estudo foi identificar e apresentar a distribuição espacial por estado do Nordeste dos principais TMCs que geram afastamento de trabalhadores da atividade laboral.

MÉTODOS

Tratou-se de um estudo descritivo com desenho ecológico de série temporal, cuja finalidade foi identificar a distribuição de TMC em trabalhadores na região Nordeste. Dessa forma, considerou-se como variável dependente a distribuição de TMCs nos trabalhadores categorizados conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Esses dados foram extraídos a partir do perfil de afastamentos por meio do INSS, cadastrados no Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab)⁹ no período de 2012 a 2018 como afastamentos mentais e comportamentais, conforme o Capítulo V da CID-10.

Como subsídio para a condução e comunicação da pesquisa, utilizou-se a lista de verificação para estudos observacionais Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)¹⁰.

O Brasil é dividido em cinco regiões, sendo elas Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Além

disso, é composto por 26 estados e um Distrito Federal. A população projetada para a área de estudo para o ano de 2019 era de 210.147.125 habitantes, ocupando 8.510.820,623 km², de acordo com as projeções populacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)¹¹.

A escolha da região Nordeste deu-se por dois motivos: o primeiro por ser a região do país na qual se concentra o maior número de estados, sendo eles Bahia (BA), Pernambuco (PE), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Rio Grande do Norte (RN), Piauí (PI), Alagoas (AL) e Sergipe (SE), e o segundo por ser a segunda região mais populosa, com cerca de 56.560.081 habitantes¹¹. Esses fatores corroboram uma maior apreciação da diversidade entre os cenários analisados e os fatores associados à sua ocorrência.

Foram contemplados os registros sobre TMCs entre trabalhadores classificados pela CBO que tenham obtido afastamento laboral em decorrência de TMC. A coleta foi realizada no SmartLab⁹ mediante o *download* das informações no mês de março de 2020. As planilhas do SmartLab apresentam dados estatísticos das informações apresentadas pelo Observatório.

Do IBGE¹¹, foram obtidos os dados da população para o ano de 2018 em cada estado. Como variável dependente, obtivemos o coeficiente geral dos TMCs e as variáveis cadastradas no SmartLab na seção Perfil dos Afastamentos – INSS, que contém afastamentos por agravo; afastamentos por causas externas; afastamentos conforme os tipos de doenças; afastamentos conforme a classificação internacional de doenças e atividades econômicas. Os auxílios-doença foram subclassificados em afastamentos acidentários (B91) e não acidentários (B31), conforme a classificação do SmartLab⁹.

A análise foi realizada por meio da construção de um algoritmo utilizando a linguagem de programação Python (versão 3.7.6) e o pacote Python Matplotlib para geração de gráficos (<https://matplotlib.org/>), a ferramenta Matplotlib Basemap para geração de mapas (<https://matplotlib.org/basemap/index.html>) e o Shapefile gadm36 BRA 1.shp (<https://gadm.org/index.html>) para geração das fronteiras dos estados brasileiros.

Para cálculo da porcentagem local de cada estado, foi utilizada a seguinte equação:

$$\text{Porcentagem local (P)} = \frac{\text{número de casos de um transtorno específico (n)}}{\text{número de habitantes de um dado estado (N)}} \times 100, \text{ ou seja, } P = n / N \times 100.$$

A porcentagem local de cada estado foi representada por uma cor específica dentro de uma barra de cores de referência (escala de cores distintas para B31 e B91). Como o número de habitantes de cada estado e, consequentemente, os números de casos estão diretamente relacionados à sua extensão territorial, foi avaliado se havia relação entre o número de casos e o número de habitantes, observando um parâmetro que poderá ser comparado entre os estados.

Para o desenvolvimento deste estudo, não foi necessária aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), uma vez que foram utilizados dados de domínio público, de acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

O grupo de afastamento por TMCs representou um número significativo de 135,8 mil casos para B31 e de 12,8 mil para B91 entre os estados da região Nordeste, que foram notificados entre o período de 2012 e 2018.

Entre os estados do Nordeste, destacam-se a BA e o RN como os que apresentaram os maiores números de casos notificados para a variável afastamentos, conforme a CID-10. O estado da BA apresentou o maior número para a variável B31, com 33.158 casos, e o RN, para B91, com 2.441 casos.

Comparando a relação entre o número de casos e o número de habitantes, o RN mostrou o maior índice percentual de TMCs em comparação com os demais estados da região, representando 0,67% de B31 e 0,07% de B91. O MA apresentou o menor índice de notificação: 0,16% de B31 e 0,008% de B91.

Entre as principais doenças que resultam em afastamento dos trabalhadores das atividades laborais listadas no capítulo V, encontram-se episódios depressivos (F32); reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (F43); TMCs devido ao uso de álcool (F10); transtorno afetivo bipolar (F31); esquizofrenia (F20); transtornos fóbico-ansiosos (F40); e outros transtornos mentais devido a lesão e disfunção cerebral e a doença física (F06).

Foi observado que o quantitativo de afastamentos comparado ao número de habitantes aponta para uma disparidade em um estado menos populoso, ao apresentar maior número de casos de afastamento para B31 e para B91 – isso em relação a estados maiores, conforme apresentado no mapa da Figura 1. De acordo com os dados analisados, observa-se, na Figura 1, que o RN é o estado da região Nordeste que concentra o maior percentual de casos de afastamento de trabalhadores por TMCs entre as doenças apresentadas no capítulo V.

Os transtornos com maior número de notificações entre os estados analisados foram os transtornos fóbico-ansiosos (F40) para B31 e B91, conforme apresentado na Figura 2. No período analisado, esses transtornos (F40) apresentaram um total de 272 mil notificações de afastamento laboral para B91 e de 2 mil para B31. O RN apresentou o maior número de notificações de afastamento por número de habitantes para esses transtornos, com 0,17% das notificações para B31, e o AL, para B91, com 0,022%. Já o PE apresentou a menor notificação por transtornos fóbico-ansiosos (F40), com 0,023% para B31 e 0,001% para B91.

As atividades econômicas que mais expõem os trabalhadores ao afastamento laboral por TMCs foram

relacionadas conforme as áreas econômicas que mais tiveram notificações por afastamento. Na Tabela 1, destacam-se as 30 áreas que mais obtiveram notificações entre os estados. Entre todas as atividades econômicas ativamente legalizadas no Brasil, foram consideradas as que apresentaram acima de 100 notificações por afastamento por B31 e B91 para o período analisado.

As atividades econômicas, conforme o registro de afastamento, foram classificadas entre as 30 principais áreas que obtiveram mais afastamento, sendo organizadas por divisão de valores percentuais conforme o valor máximo de cada classificação entre B31 e B91, de acordo com a Figura 3.

A Figura 3 aponta que, no *ranking* de atividades econômicas analisadas, a que mais se destaca é a administração pública em geral, significando que os trabalhadores que trabalham nesta atividade estão mais vulneráveis ao adoecimento por TMCs com B91. Já a que apresentou menor vulnerabilidade foi a administração de cartões de crédito, tanto para B31 quanto para B91. O gráfico ainda apresenta a construção de edifícios como um setor com maior vulnerabilidade para o afastamento B91 por TMCs.

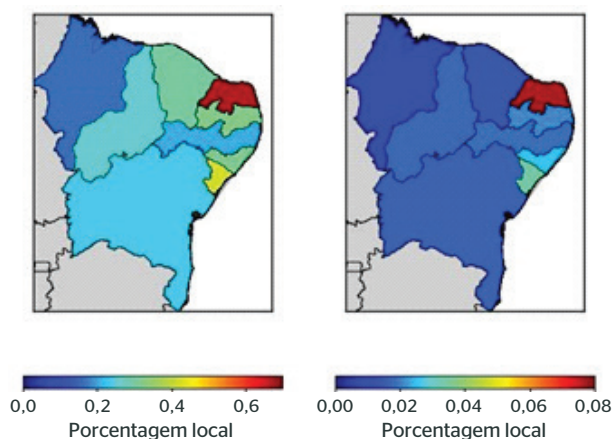


Figura 1. Percentual de casos notificados em relação ao número de habitantes por estados, afastamentos conforme os tipos de doenças (capítulo V da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde [CID-10]) entre os anos de 2012 e 2018. B91 = afastamentos acidentários; B31 = afastamentos não acidentários.

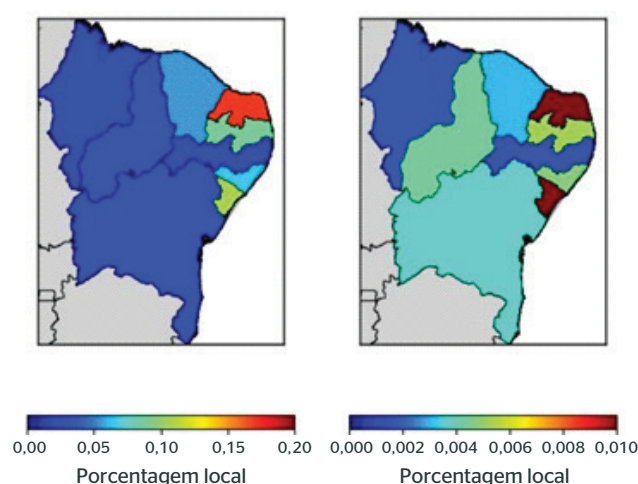


Figura 2. Percentual de casos notificados em relação ao número de habitantes por estados por transtornos fóbico-ansiosos (F40) B91 (afastamentos acidentários) e B31 (afastamentos não acidentários) entre os anos de 2012 e 2018.

A partir dos dados de afastamento por TMCs em cada estado, foram relacionadas as atividades econômicas que apresentaram um maior número e a comparação entre os estados. Em seguida, foi realizada uma normalização dos percentuais, tomando como base o estado com maior percentual, como se pode analisar na Figura 4.

A Figura 4 mostra que os trabalhadores do RN sofrem mais por TMCs comparados aos demais estados por B31, e o MA apresentou menor índice de notificações por afastamento. O gráfico também aponta o AL com maior afastamento B91 por nexos causal com a exposição no trabalho, e o MA com o menor índice de afastamento.

Tabela 1. Relação das atividades econômicas que mais obtiveram notificações no Nordeste por B91 (afastamentos acidentários) e B31 (afastamentos não acidentários) entre os anos de 2012 e 2018

Classificação	Descrição da atividade
1	Administração de cartões de crédito
2	Administração pública em geral
3	Atividades de apoio à gestão de saúde
4	Atividades de associações de defesa de direitos sociais
5	Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
6	Atividades de atendimento hospitalar
7	Atividades de correio
8	Atividades de teleatendimento
9	Atividades de transporte de valores
10	Atividades de vigilância e segurança privada
11	Bancos comerciais
12	Bancos múltiplos, com carteira comercial
13	Caixas econômicas
14	Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios
15	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção
16	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
17	Condomínios prediais
18	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
19	Construção de edifícios
20	Ensino fundamental
21	Fabricação de açúcar em bruto
22	Fabricação de calçados de couro
23	Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
24	Fabricação de calçados de material sintético
25	Fabricação de tênis de qualquer material
26	Limpeza em prédios e em domicílios
27	Locação de mão de obra temporária
28	Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
29	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
30	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana

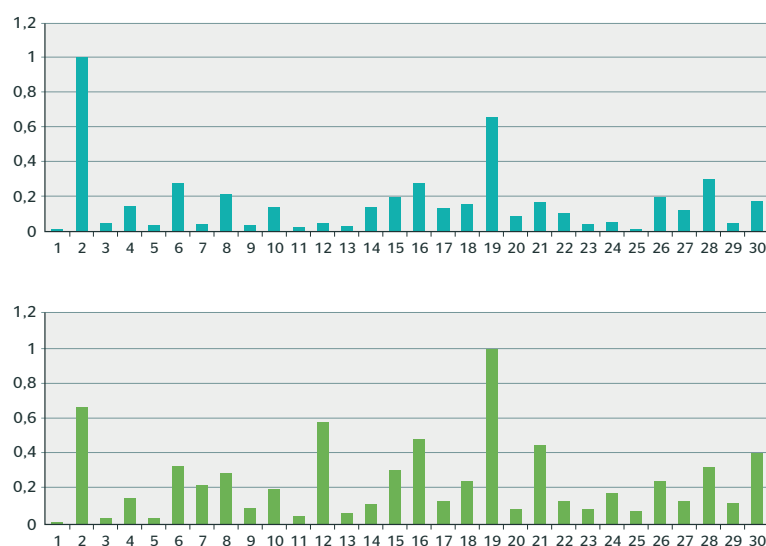


Figura 3. Relação de proporcionalidade entre as atividades econômicas notificadas por B91 (afastamentos acidentários) e B31 (afastamentos não acidentários) entre os anos de 2012 e 2018. 1 = administração de cartões de crédito; 2 = administração pública em geral; 3 = atividades de apoio à gestão de saúde; 4 = atividades de associações de defesa de direitos sociais; 5 = atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; 6 = atividades de atendimento hospitalar; 7 = atividades de correio; 8 = atividades de teleatendimento; 9 = atividades de transporte de valores; 10 = atividades de vigilância e segurança privada; 11 = bancos comerciais; 12 = bancos múltiplos, com carteira comercial; 13 = caixas econômicas; 14 = comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios; 15 = comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção; 16 = comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados; 17 = condomínios prediais; 18 = confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; 19 = construção de edifícios; 20 = ensino fundamental; 21 = fabricação de açúcar em bruto; 22 = fabricação de calçados de couro; 23 = fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente; 24 = fabricação de calçados de material sintético; 25 = fabricação de tênis de qualquer material; 26 = limpeza em prédios e em domicílios; 27 = locação de mão de obra temporária; 28 = restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas; 29 = transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional; 30 = transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana.



Figura 4. Relação de proporcionalidade entre estados com base em afastamentos B91 (afastamentos acidentários) e B31 (afastamentos não acidentários) em relação às atividades econômicas entre os anos de 2012 e 2018. AL = Alagoas; BA = Bahia; CE = Ceará; MA = Maranhão; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; RN = Rio Grande do Norte; SE = Sergipe.

DISCUSSÃO

O quantitativo de benefícios concedidos por afastamento decorrente de TMCs na região Nordeste representa um fator preocupante e leva à reflexão ao considerar a individualidade do trabalhador adoecido⁹. O trabalho pode ser considerado como promotor de saúde para a pessoa que trabalha, de modo a refletir nas condições coletivas, sociais e econômicas¹². As perdas por afastamento laboral têm impacto na produtividade econômica local, regional e nacional, interferindo entre 70 e 80% diretamente na renda do país oriunda do trabalho. O Nordeste é a segunda região com o maior número de trabalhadores afastados^{9,13}.

De acordo com os resultados, os estados que se destacaram em notificações por afastamento foram a BA (por B31) e o RN (por B91). Foi observado, em um estudo realizado na BA, o crescente registro de casos por afastamento do trabalho no INSS, com maior prevalência do sexo masculino relacionado ao grupamento F40-F48 da CID-10 em 2012. Esse grupo também foi identificado em outro estudo¹². No mesmo estudo, identificou-se que a instituição que mais notificou afastamentos foi o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST), mas que apresenta falha na associação do desfecho do nexo causal com o trabalho¹². De modo a buscar soluções, foi implantado o Protocolo de Atenção à Saúde Mental e Trabalho em 2014 na BA para capacitar os trabalhadores no diagnóstico precoce¹³.

O RN representa o maior índice de TMCs quando comparado aos demais estados analisados. Isso também foi observado em um estudo que analisou transtornos mentais relacionados ao trabalho (TMRTs). Destacam-se o predomínio (36,5%) de notificações entre 2007 e 2016 e a concentração de notificações em municípios mais populosos, como Natal e Mossoró¹⁴. O quantitativo de notificações pode estar relacionado ao fato de os dois municípios possuírem sedes do CEREST e concentrarem as principais atividades econômicas do estado¹⁴.

O grupo de transtornos mais prevalente evidenciado por este estudo também foi observado em outras pesquisas^{5,13-15}. Entre os transtornos mentais que mais impactam o afastamento laboral dos trabalhadores da região Nordeste, destacam-se os transtornos fóbico-ansiosos, com prevalência no RN para B31 e em AL para B91. Observou-se também, na análise da distribuição dos principais TMCs entre estados, que o estado com menos notificações foi o PE. Um estudo sobre benefícios previdenciários constatou que, no AL, a

causa para o desencadeamento de TMCs está relacionada à concentração dos trabalhadores na capital, como já observado no RN⁵⁻¹⁵.

A concentração do trabalho nas capitais dos estados é uma característica do avanço da urbanização no Brasil, evidenciada em alguns estudos como fator desencadeador de TMC¹³⁻¹⁶. O absenteísmo pode estar relacionado à exigência do mercado de trabalho e às imposições de ritmo, produção, produtividade e qualidade, sendo a soma dessas exigências o que paralisa o funcionamento psíquico, desencadeando transtornos fóbico-ansiosos⁵.

Em relação à atividade econômica, a administração de cartões de crédito foi a atividade que menos apresentou notificações de afastamentos de trabalhadores para B31 e para B91. A administração pública representou a atividade que mais obteve notificações. Em uma pesquisa realizada no Tocantins com servidores públicos sobre a correlação de atividades econômicas e TMCs, identificou-se que o adoecimento mental representava 29,2% dos afastamentos, destacando-se a existência de um quantitativo maior, mas não reportado por muitos trabalhadores devido à apreensão da exposição a preconceitos no ambiente de trabalho¹⁶.

Um estudo realizado na BA destaca que, apesar do baixo registro da ocupação no momento da notificação, foram apontadas a administração pública e a atividade de transporte terrestre como as que mais acometem os trabalhadores por TMCs entre 2007 e 2013¹³. Entre as hipóteses para a relação do desfecho do adoecimento na administração pública levantadas por alguns estudos, estão o tempo no serviço público, a mudança de estado para assumir o cargo, a não adaptação ao ambiente de trabalho, a terceirização de setores públicos, a frustração profissional, a degradação das condições de trabalho e a responsabilização pelas deficiências dos serviços^{6,13,16}.

A ocupação de construção de edifícios se sobressaiu para B91 e é a segunda atividade com mais notificação no adoecimento dessa classe profissional para B31. A exposição a acidentes, a desvalorização da mão de obra e o afastamento do convívio familiar podem estar relacionados com o adoecimento. Um estudo apontou a prevalência de auxílio-doença entre trabalhadores da construção de edifícios, e, com isso, foi possível observar a relação do adoecimento por TMCs com o uso de múltiplas drogas somadas ao uso de outras substâncias psicoativas como forma de alívio do sofrimento. Ressalta-se que o desenvolvimento de compulsões por substâncias psicoativas também está

relacionado aos TMCs. Medidas preventivas precisam ser adotadas dado o risco iminente, tanto físico quanto psíquico, relacionado à ocupação¹⁷.

Para a proporcionalidade entre estados que apresentam afastamento na atividade econômica, o RN aparece com a maior proporção, seguido de AL e SE, para afastamentos não relacionados ao trabalho. O MA obteve a melhor relação entre a atividade econômica e o não adoecimento de seus trabalhadores entre B31 e B91. No que concerne o afastamento relacionado ao trabalho e o adoecimento mental do trabalhador, o AL alcançou a maior proporção, seguido do RN e PE.

A relação da distribuição no RN e em AL já foi mencionada. O destaque está no SE e no MA, visto que, em um estudo que analisou os TMRTs entre 2007 e 2016, identificou-se que o SE foi o terceiro estado que menos notificou casos de TMRTs na região Nordeste, e o MA foi o que menos notificou, com 28 casos. Já o PE foi observado pelo mesmo estudo como o segundo estado que mais notificou, o que não destoia dos achados do presente estudo¹⁴.

Destaca-se a necessidade de estudos que abordem variáveis socioeconômicas e com características do ambiente laboral notificado, o que não foi pretendido por este estudo. A urgência em evidenciar discussões em torno dessa temática é imposta pela grave crise mundial relacionada ao adoecimento mental da população evidenciado pela OMS e pela OIT, sendo a classe trabalhadora uma das mais acometidas¹⁶⁻¹⁸.

Entre as limitações do estudo, destacam-se as barreiras próprias dos estudos ecológicos, como a impossibilidade de fazer inferências causais sobre a exposição dos TMCs em nível individual, bem como a falta de controle dos fatores de confusão, que pode ocasionar dificuldades na interpretação.

CONCLUSÕES

A compreensão dos fenômenos que acarretam o afastamento do trabalhador de sua atividade laboral é um dos objetivos da política da saúde do trabalhador. O presente estudo, por sua vez, contribui para o conhecimento da análise geográfica da região Nordeste quanto ao afastamento por TMCs em trabalhadores.

Entre os TMCs, os transtornos fóbico-ansiosos apresentaram-se como destaque e enquadraram o RN como o estado com maiores casos de notificações em

trabalhadores para B31 e o AL para B91, constatando, assim, a necessidade da adoção de medidas que previnam o adoecimento mental de trabalhadores, aplicando programas que promovam a saúde psicológica desse grupo.

A administração pública representa o maior índice de afastamento laboral em toda a região Nordeste para B31, não correlacionado com o trabalho; entretanto, pode evidenciar uma subnotificação do nexo causal com a atividade laboral. Algumas causas, como a flexibilização do assecuramento dos direitos trabalhistas, a precarização das condições de trabalho e a centralidade do vínculo de trabalho nas capitais dos estados, podem contribuir para que os índices de afastamento por TMCs continuem aumentando nos próximos anos. Destaca-se, ainda, a subnotificação associada ao despreparo do diagnóstico precoce.

É imprescindível que a sociedade compreenda e se conscientize sobre o processo de saúde-doença associado ao trabalho. É necessário que seja prioridade para as esferas legislativas e executivas do país a adoção de mecanismos relacionados às políticas públicas efetivas no enfrentamento desta grave crise de saúde pública. É preciso que haja utilização de mecanismos que busquem identificar os aspectos que levam ao adoecimento mental do trabalhador e, consequentemente, a seu afastamento da atividade laboral. A OMS e a OIT evidenciam a necessidade de identificação dos principais transtornos mentais e atividades econômicas que estão levando a classe trabalhadora ao adoecimento mental, dada a urgência de levantar discussões em torno dessa temática que impacta diretamente nas condições sociais e econômicas do país.

HOMENAGEM

A autora Vanessa Cristina de Góes e Silva Faustino da Costa participou ativamente no desenvolvimento do artigo, porém infelizmente veio a falecer antes de sua publicação. Agradecemos a ela pelas valiosas contribuições para este estudo.

Contribuição dos autores

PBSM, IBC, VCGSFC e JLC foram responsáveis pela concepção do estudo, análise formal, tratamento de dados, redação – esboço original e redação – revisão & edição. Todos os autores aprovaram a versão final submetida e assumem responsabilidade pública por todos os aspectos do trabalho.

REFERÊNCIAS

1. Dutra FCMS, Costa LC, Sampaio RF. A influência do afastamento do trabalho na percepção de saúde e qualidade de vida de indivíduos adultos. *Fisioter Pesq*. 2016;23(1):98-104.
2. Oliveira AN. Saúde mental e desemprego: configurações da vivência psicológica do sujeito desempregado e suas psicopatologias [monografia]. Anápolis: Faculdade Católica de Anápolis; 2015.
3. Silva CO, Ramminger T. O trabalho como operador de saúde. *Cienc Saude Colet*. 2014;19(12):4751-8.
4. Fernandes MA, Santos JDM, Moraes LMV, Lima JSR, Feitosa CDA, Sousa LFC. Transtornos mentais e comportamentais em trabalhadores: estudo sobre os afastamentos laborais. *Rev Esc Enferm USP*. 2018;52:e03396.
5. Fernandes MA, Sales JVS, Feitosa CDA, Costa RS, Vieira CPB, Silva JS. Benefícios previdenciários por transtornos mentais e comportamentais em trabalhadores do Piauí em 2014. *Rev Bras Med Trab*. 2019;17(1):99-105.
6. Bastos MLA, Silva Junior GB, Domingos ETC, Araújo RMO, Santos AL. Afastamentos do trabalho por transtornos mentais: um estudo de caso com servidores públicos em uma instituição de ensino no Ceará, Brasil. *Rev Bras Med Trab*. 2018;16(1):53-9.
7. Silva-Junior JS, Fischer FM. Afastamento do trabalho por transtornos mentais e estressores psicossociais ocupacionais. *Rev Bras Epidemiol*. 2015;18(4):735-44.
8. Brasil, Ministério da Previdência Social. Anuário Estatístico da Previdência Social [Internet]. Brasília: Ministério da Previdência Social; 2020 [citado em 25 mar. 2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-social/arquivos/versao-online-aeps-2020/secao-i-beneficios/subsecao-b-beneficios-emitidos/capitulo-10-2013-auxilios>
9. Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, Smartlab. Incidência e prevalência de afastamentos - INSS [Internet]. Brasília: Ministério Público do Trabalho; 2020 [citado em 1 mai. 2020]. Disponível em: <https://smartlabbr.org/sst/localidade/0?dimensao=prevalenciaAfastamentos>
10. Malta M, Cardoso LO, Bastos FI, Magnanini MMF, Silva CMFP. Iniciativa STROBE: subsídios para a comunicação de estudos observacionais. *Rev Saude Publica*. 2010;44(3):559-65.
11. Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2019. Informações por Cidades e Estados [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2019 [citado 1 maio 2020]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rn.html>
12. Mendes R. Saúde/doença mental e trabalho: reflexões (contra hegemônicas) sobre algumas dimensões negligenciadas. *Rev Laborativa*. 2017;6(1):4-26.
13. Bahia, Secretaria da Saúde do Estado. Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador, Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador. Protocolo de atenção à saúde mental e trabalho [Internet]. Salvador: DIVAST; 2014 [citado 1 mai. 2020]. Disponível em: https://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/ProtocoloSaudeMentalTrabalho_WEB_FINAL_2014.pdf
14. Costa SS, Cardim A. Perfil epidemiológico dos transtornos mentais relacionados ao trabalho na região Nordeste do Brasil, no período de 2007 a 2016 [artigo de especialização]. Salvador: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; 2017.
15. Gomes PB, Rezende MC. Análise da série histórica dos afastamentos de trabalhadores por quadro de transtornos mentais e comportamentais (2008-2017). *Pensar Acad*. 2020;18(2):322-38.
16. Oliveira, LA, Baldaçara LR, Maia MZB. Afastamentos por transtornos mentais entre servidores públicos federais no Tocantins. *Rev Bras Saude Ocup*. 2015;40(132):156-69.
17. Mello TA, Barbosa-Branco A. Prevalência de benefícios auxílio-doença entre trabalhadores da Construção no Brasil em 2009. *Rev Bras Saude Ocup*. 2014;39(130):224-38.
18. Ribeiro HKP, Santos JDM, Silva MG, Medeiros FDA, Fernandes MA. Transtornos de ansiedade como causa de afastamentos laborais. *Rev Bras Saude Ocup*. 2019;44:e1.

Endereço para correspondência: Paula Beatriz de Souza Mendonça - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Saúde Coletiva - Avenida Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário - Bairro Lagoa Nova - Natal (RN), Brasil - E-mail: paulabsmendonca@gmail.com

